

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2025

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

F.P.4

SECCIÓ:	G0110	Sanitat
SERVICI:	G011002	SA de Sanitat
CENTRE GESTOR:	G01100201	DG d' Atenció Hospitalària
PROGRAMA:	412B28	Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

1. Adaptar els Hospitals d'Atenció a Crònics i Llarga Estada (HACLE) a l'estratègia de cronicitat de la Comunitat Valenciana.
2. Marcar nous objectius del Pla Integral de Cures Pal·liatives de la Comunitat Valenciana per als HACLES.
3. Implementar la coordinació sociosanitària en la Comunitat Valenciana.
4. Posar en marxa la bona pràctica assistencial convalsència, rehabilitació i cures pal·liatives per als HACLES.
5. Garantir una atenció integral en pacients amb Dany Cerebral Adquirit (DCA) en la Comunitat Valenciana.
6. Promoure l'atenció centrada en el o la pacient per equips interdisciplinaris.
7. Necessitat de disminuir la variabilitat clínica en HACLES.
8. Necessitat de millorar la coordinació i establir actuacions conjuntes amb la VICIPI.
9. Necessitat de millorar els sistemes d'informació i la seua accessibilitat en HACLES.
10. Necessitat de potenciar l'apoderament de les persones i usuàries i la seua participació en tot allò que els concernix en HACLES.
11. Necessitat de participació de professionals en la planificació, organització i avaluació dels servicis en HACLES.

OBJECTIU BÀSIC

- 1.1. Implementar l'Estratègia d'Atenció a la cronicitat de la Conselleria de Sanitat en HACLES.
- 2.1. Millorar l'atenció hospitalària de mitjana i llarga estada de les cures pal·liatives.
- 2.2. Fomentar, a més de l'augment de llits, la incorporació de les alternatives a l'hospitalització convencional i els HACLE als circuits d'atenció integrada en els departaments, per a pacients crònics complexos i pal·liatius.
- 3.1. Desenvolupar mecanismes de coordinació entre els HACLES i els centres residencials.
- 4.1. Desenvolupar la bona pràctica assistencial, coordinant els HACLE amb altres nivells assistencials per a l'atenció de pacients amb cronicitat.
- 5.1. Consolidar les Unitats de Dany Cerebral Adquirit d'HACLE en l'estratègia del DCA.
- 5.2. Assegurar l'equitat entre els diferents departaments de salut en la atenció sanitària i social a pacients amb dany cerebral adquirit establint les comissions multidisciplinàries departamentals de DCA.
- 6.1. Potenciar l'atenció a pacients mitjançant equips interdisciplinaris.
- 7.1. Elaborar, implementar i avaluar processos assistencials, protocols i programes tenint en compte la perspectiva de gènere, la variable edat i els grups vulnerables que garantisquen una atenció de qualitat i minimitzen la variabilitat clínica.
- 8.1. Millorar l'accessibilitat per a les persones en els dos sentits.
- 8.2. Establir mecanismes procedimentals de coordinació entre el personal de psicologia clínica i el personal de psicologia generalista sanitària.
- 9.1. Millorar els sistemes d'informació i la seua utilització per a la planificació, avaluació i atenció en HACLES.
- 10.1. Crear mecanismes per a la participació de pacients i famílies, incloent l'avaluació i planificació dels servicis.
- 10.2. Millorar la participació de les persones usuàries en tot el relatiu al seu tractament.
- 11.1. Crear mecanismes per a la participació de professionals en la planificació, organització i avaluació dels servicis.

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 1.1.1. Definir nous perfils de pacients en l'atenció de mitjana i llarga estada.
- 2.1.1. Consolidar l'atenció en pacients amb cronicitat i necessitats pal·liatives en els HACLES.
- 2.1.2. Consolidar el Pla d'Atenció Individualitzada en els HACLES.
- 2.2.1. Incorporar alternatives a l'hospitalització convencional i d'HACLE als circuits d'atenció integrada en els departaments per a pacients crònics complexos i pal·liatius.
- 3.1.1. Establir els circuits assistencials per a l'atenció integral de pacients amb cronicitat i institucionalització.
- 3.1.2. Consensuar criteris per a la derivació i coordinació en els departaments per a l'atenció a la demència i les cures pal·liatives.

SECCIÓ:	G0110	Sanitat
SERVICI:	G011002	SA de Sanitat
CENTRE GESTOR:	G01100201	DG d' Atenció Hospitalària
PROGRAMA:	412B28	Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER A ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 4.1.1. Potenciar la investigació multicèntrica de l'atenció a la cronicitat i cures pal·liatives.
- 5.1.1. Consensuar la metodologia d'atenció i l'avaluació del Dany Cerebral Adquirit (DCA) en els HACLEs.
- 5.1.2. Impulsar la Rehabilitació ambulatoria com a continuïtat assistencial per a pacients amb DCA en els HACLEs.
- 5.1.3. Assegurar l'equitat entre els diferents departaments de salut en l'atenció a la persona amb dany cerebral adquirit establint en les comissions multidisciplinàries departamentals un full de ruta individualitzada de cada pacient per a la màxima recuperació i el major grau d'autonomia tant durant la fase d'hospitalització com l'ambulatoria, contemplant els aspectes sanitaris i socials.
- 5.1.4. Incorporar i/o augmentar de manera real des de l'any vinent, el número de mèdics/metgesses geriatres i infermeres geriatres als hospitals de mitjana i llarga estada amb la finalitat d'aconseguir la necessitat d'atenció a pacients adaptant-se a l'estratègia de cronicitat de la Comunitat Valenciana.
- 5.1.5. Dotar de personal l'oficina autonòmica de DCA.
- 5.2.1. Establir en les comissions multidisciplinàries departamentals un full de ruta individualitzat de cada pacient amb dany cerebral adquirit per a la màxima recuperació i el major grau d'autonomia tant durant la fase d'hospitalització com l'ambulatoria, contemplant els aspectes sanitaris i socials.
- 5.2.2. Constituir les comissions multidisciplinàries departamentals i/o interdepartamentals de dany cerebral adquirit, que comptaran almenys amb personal mèdic, infermeria, fisioteràpia, treball social, logopèdia, membres de les unitats i equips d'ictus, neurocirurgia, intensius, rehabilitació, unitat de dany cerebral d'HACLEs, UHD i infermeria gestora de casos.
- 5.2.3. Establir les comissions multidisciplinàries departamentals de mal cerebral adquirit.
- 6.1.1. Implantar protocols d'ingrés/derivació entre recursos sanitaris i socials per a persones amb condicions cròniques i dependència.
- 7.1.1. Implementar el programa d'atenció per a persones amb TCA.
- 7.1.2. Implementar el programa d'atenció a persones amb Patologia Dual.
- 7.1.3. Implementar el programa d'atenció a persones amb el diagnòstic de TDAH.
- 7.1.4. Implementar el programa d'atenció a persones amb el diagnòstic de TP.
- 7.1.5. Implementar el programa d'atenció a persones ancianes.
- 7.1.6. Implementar el programa d'atenció a persones DCA.
- 7.1.7. Avaluar els actuals protocols d'atenció a les urgències.
- 7.1.8. Incorporació de la perspectiva de gènere en els protocols, programes, etc.
- 8.1.1. Eliminar barreres a l'accés i la comunicació a nivell local-comarcal.
- 8.2.1. Coordinar el personal de psicologia i psicologia generalista sanitària.
- 9.1.1. Dissenyar un sistema d'informació integrat i específic.
- 10.1.1. Incloure a les persones usuàries i als seus familiars en les comissions i grups de treball.
- 10.1.2. Desenvolupar una estratègia de difusió per a persones usuàries i familiars sobre drets, recursos i prestacions.
- 10.2.1. Incloure la PAD en la HCI.
- 11.1.1. Crear mecanismes per a la participació de professionals en la planificació, organització i avaluació dels serveis.